Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Vara Única da Comarca de Passira

Pç Severino Ferreira, 59, Centro, PASSIRA - PE - CEP: 55650-000 - F:(81) 36512820

Processo nº **0000671-77.2023.8.17.3070**

AUTOR(A): SEVERINO JERONIMO DE MOURA

RÉU: ESTADO DE PERNAMBUCO

SENTENÇA

SEVERINO JERONIMO DE MOURA, qualificado nos autos, propôs ***AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER*** em face do **ESTADO DE PERNAMBUCO**, conforme exordial ID 140328432.

Alega, em apertada síntese, que o requerente com 77 (setenta e sete) anos de vida, é portador de câncer de RIM (CID – 10: C64), estágio IV, avançado com metástases pulmonares em aumento. Afirma, que de acordo com a prescrição médica, o paciente, ora requerente, precisa fazer uso do medicamento NIVOLUMAB 480mg, a cada 04 (quatro) semanas por tempo indeterminado. Esclarece também que por ser pessoa hipossuficiente, não possui condições financeiras de arcar com a medicação de alto custo. Uma caixa do medicamento de 100mg com apenas 01 (uma) ampola custa em média mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, diz que buscou amparo no SUS - Sistema Único de Saúde - para o recebimento do medicamento, mas foi informado que tal medicamento apesar de constar na lista para distribuição, conforme ficha técnica em anexo, requereu o autor na esfera municipal e estadual, mas o pedido foi indeferido.

Juntou documentos, dentre eles laudo médico ID 140328439.

Concedida tutela de urgência em decisão ID 140542860.

Contestação no ID 141112500, em que alega preliminarmente acerca da solidariedade dos entes públicos em demandas de saúde e incorreção do valor atribuído à causa.

Réplica no ID 144969904.

Petição da parte autora informando o descumprimento da ordem judicial, ID 145198623.

Deferida penhora on-line (ID 161804968), expedido o respectivo alvará, em ID 170033874.

Petição da parte autora informando, que o valor liberado somente foi usado para a compra de utilização do medicamento pelo autor, apenas de 01 (um) ciclo, ou seja, tratamento apenas para 01 (mês), no valor de R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais). Que o excedente de R$ 26.385,41 (vinte e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos), foi devolvido, via depósito judicial, por fim requer o bloqueio e levantamento, via alvará judicial, do valor de R$ 249.600,00 (duzentos e quarenta e nove mil e seiscentos reais), referente a compra/aquisição relativa a 04 (quatro) meses de uso do medicamento, conforme laudo médico atualizado.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Verifico que o feito encontra-se pronto para julgamento, sobretudo por não haver a necessidade de produção de outras provas, em atenção ao art. 355 do Código de Processo Civil. Nessa medida, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito comporta julgamento do mérito.

Da preliminar da solidariedade dos entes públicos na demanda de saúde

As ações e serviços de saúde, aí incluídos o fornecimento de medicamento, é de responsabilidade solidária entre as três esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal), cabendo, portanto, ao autor escolher contra quem demandar. Nesse sentido, cola-se julgado da lavra da Eminente Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal:

> EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.8.2008.
>
> A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO : ARE 738729 RS. Rel. Min. Rosa Weber. Julgado em: 25/06/2013).

Nesse sentido, embora a *Lex Legum* tenha afirmado que a assistência à saúde é dever do Estado, enquanto gênero, do qual são espécies a União, os Estados (unidades da federação) e Municípios, ressalvou que o sistema único de saúde será regido com base na descentralização administrativa, vale dizer, cada esfera de governo possui um grau de responsabilidade ou competência na gestão dos serviços de saúde.

Portanto, a responsabilidade questionada por ser solidária nos três níveis federados, aos quais cabem, a nível administrativo, as eventuais e consequentes compensações. Assim, tenho que o demandado pode ocupar, sozinho, o polo passivo. Desta forma, **rejeito a preliminar suscitada**.

Da preliminar de incorreção do valor da causa

Sustentou o réu que o valor da causa é inestimável, e não o valor atribuído pelo autor, qual seja, R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Defendeu o réu que a sucumbência, inclusive, pode ser fixada por equidade pelo juízo, atribuindo-se o valor da causa a R$1.000,00 (um mil reais) e com fixação equitativa de honorários de sucumbência.

Entendo que a preliminar pode ser acolhida. De fato, não há como, ao menos no momento e pelo que se relatou na petição, como se comprovar o valor real dos gastos. Da mesma maneira, havendo a possibilidade de fixação dos honorários por equidade em causas de valor inestimável, não verifico nenhum prejuízo ao direito subjetivo do vencedor em receber os honorários sucumbenciais.

Assim sendo, **ACOLHO** a preliminar.

Passo a analisar o mérito.

Consoante dispõe a Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (C.F., art. 196).

Segundo dispõe José Afonso da Silva, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, acrescentando que, tratando-se de um direito positivo, exige prestações do Estado e impõe aos entes públicos a realização de determinadas tarefas, de cujo cumprimento depende a própria realização do direito [1] (/////tjpe195009/arquivos_bu%C3%ADque/02%20-%20SENTEN%C3%87AS/2020/05%20-%20MAIO/28-05-2020/0000505-17.2018.8.17.2360.doc#_ftn1).

Sobre o dever do Estado e as prestações de saúde, assim se manifesta o referido autor:

> *"A norma do art. 196 é perfeita, porque estabelece explicitamente uma relação jurídica constitucional em que, de um lado, se acham o direito que ela confere, pela cláusula "a sáude é direito de todos", assim como os sujeitos desse direito, expressos pelo signo "todos", que é signo de universalização, mas com destinação precisa aos brasileiros e estrangeiros residentes – a norma reforça esse sentido ao prever o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde -, e, de outro lado, a obrigação correspondente, na claúsula "a saúde é dever do Estado", compreendendo aqui a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que podem cumprir o dever diretamente ou por via de entidade da Administração indireta"[2]* (/////tjpe195009/arquivos_bu%C3%ADque/02%20-%20SENTEN%C3%87AS/2020/05%20-%20MAIO/28-05-2020/0000505-17.2018.8.17.2360.doc#_ftn2).

A Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, disciplina que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2, *caput*).

A Magna Carta prescreveu, ainda, que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II – **atendimento integral**, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e, III – participação da comunidade (art. 198).

Além dos princípios acima descritos, contudo, faz-se imperioso observar que, integrando a saúde, juntamente com a previdência e a assistência social, a Seguridade Social, impõe-se, também, a sua sujeição às seguintes diretrizes: a) **universalidade de cobertura e do atendimento**; b) uniformidade dos serviços às populações urbanas e rurais; seletividade e distributividade na prestação dos serviços; c) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados (CF, art. 194).

Vê-se, assim, que foi construído todo um arcabouço legislativo, constitucional e infraconstitucional, com vistas à implementação do direito à saúde, o que não pode ser desconsiderado em caso como o dos autos, mormente quando, hodiernamente, a doutrina vem desenvolvendo uma nova perspectiva em relação ao constitucionalismo, por intermédio do qual se busca não apenas a limitação do poder político, mas, sobretudo, a **eficácia da constituição**[3] (/////tjpe195009/arquivos_bu%C3%ADque/02%20-%20SENTEN%C3%87AS/2020/05%20-%20MAIO/28-05-2020/0000505-17.2018.8.17.2360.doc#_ftn3).

Vale ressaltar que o simples cumprimento da decisão judicial, por meio da concessão de antecipação de tutela, não importa em perda do objeto, pois ao proceder com o fornecimento do fármaco requerido na inicial, o réu apenas cumpriu a determinação. O fato de sobrevir a continuidade do tratamento necessário não esgota a pretensão deduzida em juízo, capaz de extinguir o processo, sem exame do mérito. Senão vejamos:

> *ESTADO DO RIO DE JANEIRO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL FAZENDÁRIA Processo no 0411208-54.2013.8.19.0001 Recorrente: Jennifer Ferreira de Sá Recorridos: Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro Sentenciante: Dr. Marcelo Mondego Relator: Juiz Luiz Fernando de Andrade Pinto Realização de cirurgia pelo sistema de saúde público. Oportuno cumprimento da tutela antecipada deferida. Perda do objeto. Não ocorrência. Necessidade de convolar o juízo temporário em definitivo. Precedentes. Direito à saúde que, compondo o núcleo irredutível do direito à vida, não transige com temperamentos ou setorização da saúde pelos entes públicos. Procedência da obrigação de fazer com a confirmação da tutela antecipada. Condenação à entrega de medicamentos e insumos correlatos que, embora não especificados na inicial, se façam necessários no curso do tratamento, desde que relacionados à mesma moléstia. Impossibilidade. Jurisprudência uníssona desta Eg. Turma Recursal Fazendária no sentido de que isso representaria burla ao pedido da correlação. Ressalva do entendimento pessoal deste Relator que, na esteira do verbete sumular nº 116 do Eg. TJRJ e da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tinha pelo provimento do recurso. Recurso conhecido e parcialmente provido, ressalvado, quanto à possibilidade de substituição dos medicamentos, o entendimento da relatoria. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Inominado nº 0277616-11.2013.8.19.0001, em que é recorrente Jennifer Ferreira de Sá e recorridos o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro. ACORDAM os Juízes que compõem a Primeira Turma Recursal Fazendária em, por UNANIMIDADE de votos, dar provimento parcial ao recurso, ressalvado, quando à possibilidade de substituição dos medicamentos, o entendimento da Relatoria, nos termos do voto do relator. R E L A T Ó R I O Tem-se obrigação de fazer para que fosse realizada a cirurgia de que necessita a parte autora... TJ-RJ - RECURSO INOMINADO RI 04112085420138190001 RJ 0411208-54.2013.8.19.0001 (TJ-RJ) Data de publicação: 16/10/2014*

No caso dos autos, verifico que as alegações constantes na exordial restaram devidamente comprovadas nos autos, sobretudo através do laudo médico (ID 174579451) acostado que informa a patologia que acomete o paciente, cuidando-se de moléstia grave.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco editou Súmula na qual reconhece ser dever do Estado o fornecimento de medicamento a cidadão carente, ainda que não conste da lista oficial do SUS, conforme se confere abaixo:

Súmula 18 do TJPE. "É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial."

Trata-se, na realidade, de entendimento assente no âmbito da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, senão vejamos:

> ***PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO. PLEITO DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO HUMANO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE***

ENFERMIDADE GRAVE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM PROMOVER A SAÚDE DOS MAIS CARENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO À UNANIMIDADE.

1. Versa a presente lide acerca do custeio de tratamento oncológico em pessoa portadora de hepatocarcinoma e Cirrose VHC.2. Segundo os laudos médicos acostados às fls. 25/26 com a declaração expressa que o paciente/apelado José Batista da Silva, possui o diagnóstico de HEPATOCARCINOMA (CID: C22), necessitando com urgência do medicamento Sorafenibe, 400g, 12 em 12 horas para tratamento oncológico.3. Discute-se, pois, o direito à vida, garantia fundamental que assiste a todas as pessoas e dever indissociável do Estado, a comprovada necessidade do medicamento e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o direito em buscar a tutela jurisdicional, face o amparo por meio de dispositivo constitucional.4. Com a entrada em vigor da Constituição de 1988, o direito à saúde foi elevado à categoria de direito subjetivo público, reconhecendo-se o sujeito como detentor do direito e o Estado o seu devedor, pressupondo o art. 196 da CF a adoção de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para a sua promoção, proteção e recuperação. 5. É de se ressaltar que o dever de assistência à saúde dos cidadãos surge como uma das formas de garantia do direito à vida, localizado no caput do art. 5º da CF, caracterizando-se, pois, como cláusula pétrea, de modo a impedir que o legislador, assim como o administrador, criem situações que impliquem esvaziamento do conteúdo desse dispositivo constitucional. De fato, o laudo médico subscrito pelo da Dr. Fábio Mesquita Moura (CRM 13204), Coordenador do Grupo de Transplante Hepático do IMIP, e que, conforme Portaria GM/MS 2439/2005, que institui a política nacional de atenção oncológica, " Em Pernambuco estão credenciados como CACON´s, os seguintes hospitais: Hospital Barão de Lucena, Hospital das Clínicas, Hospital do Câncer, Hospital Universitário Oswaldo Cruz e Instituto de medicina Integral professor Fernando Figueira"(...) 6. O IMIP também é considerado um CACON1, portanto compete ao mesmo a dispensação do medicamento solicitado, declarada a necessidade da aplicação do medicamento. Assim sendo, completamente sem fundamento a alegação do apelante de que se faz necessário que o atendimento seja prestado em unidades do SUS, que a receita médica seja emitida por um médico do sistema público de saúde, uma vez que o funcionamento da assistência oncológica no SUS possui sistemática própria via CACONs e UNACONs, conforme a Portaria nº 62, de 11/03/2009 do Ministério da Saúde. Versando, pois, a lide em apreço acerca do direito à vida, garantia fundamental que assiste a todas as pessoas e dever indissociável do Estado, a comprovada necessidade do medicamento e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o direito em buscar a tutela jurisdicional, face o amparo por meio de dispositivo constitucional.7. Outrossim, a Súmula nº 18 desta Corte de Justiça dispõe que "É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial".8. Recurso de Agravo negado provimento à unanimidade. (Agravo 369893-5 - 0104600-70.2013.8.17.0001 – Relator: Luiz Carlos Figueirêdo; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Data de Julgamento: 02/06/2015; Data da Publicação: 11/06/2015).

Cuida-se, pois, de medida imprescindível à preservação da vida e saúde da paciente, acometida por doença severa, sendo induvidosa a situação fática apresentada nos autos, mormente em face da prescrição médica apresentada por equipe que o acompanha.

Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito e **JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL** para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 140542860) e determinar ao **ESTADO DE PERNAMBUCO** que proceda com a continuidade regular e ininterrupta do fornecimento do fármaco prescrito à autora, conforme determinado na decisão antecipatória.

Em razão do pedido exposto na petição de ID 174578880 **determino a intimação da demandada para fornecer em até 24h, contando da intimação, a medicação indicada no ID 174579451. Em caso de não cumprimento, sem nova conclusão, DETERMINO o bloqueio, via SISBAJUD, referente a compra/aquisição relativa a 02 (dois) meses de uso do medicamento**, conforme laudo médico no ID 174579451, com o fim de da cumprimento a ordem judicial.

Considerando que houve a devolução de valor excedente de R$ 26.385,41 (vinte e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos), via depósito judicial (id. 174579441 e 174579445), o valor a ser bloqueado será de valor R$ 97.614,59 (noventa e sete mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos), devendo ser levantado por alvará o valor devolvido de **R$ 26.385,41** (id. 174579441 e 174579445), além do valor do bloqueio, sendo a soma dos valores o necessário para a aquisição de medicamento para dois meses de uso.

Em caso de novo pedido, deverá ser apresentado receituário médico atualizado.

Efetivado o bloqueio, **intimem-se as partes e em seguida, determino a transferência de valores para conta judicial, com expedição de alvará em favor da parte autora.**

Fica a parte autora intimada para viabilizar o cumprimento da obrigação, sendo advertida da necessidade de prestar contas, por nota fiscal, **no prazo de até 5 dias da realização do procedimento.**

Ademais, em caso de nota fiscal apresentada com valor inferior à transferência realizada, deverá o valor excedente ser devolvido efetuando-se depósito em juízo vinculado a este processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sem custas, face a Gratuidade de Justiça deferida. Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do NCPC).

Sentença não sujeita ao reexame necessário na forma do art.496, caput c/c §3º, inciso II, do CPC/2015.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

Expedientes necessários. **CUMPRA-SE.**

PASSIRA, data da assinatura digital.

Ingrid Miranda Leite

Juiz(a) de Direito

[1] (/////tjpe195009/arquivos_bu%C3%ADque/02%20-%20SENTEN%C3%87AS/2020/05%20-%20MAIO/28-05-2020/0000505-17.2018.8.17.2360.doc#_ftnref1) In. *Comentário Contextual à Constituição*. 2ª Ed. pág. 768, Ed. Malheiros, 2006.

[2] (/////tjpe195009/arquivos_bu%C3%ADque/02%20-%20SENTEN%C3%87AS/2020/05%20-%20MAIO/28-05-2020/0000505-17.2018.8.17.2360.doc#_ftnref2) José Afonso da Silva. *Comentário Contextual à Constituição*. 2ª Ed. pág. 768, Ed. Malheiros, 2006.

[3] (/////tjpe195009/arquivos_bu%C3%ADque/02%20-%20SENTEN%C3%87AS/2020/05%20-%20MAIO/28-05-2020/0000505-17.2018.8.17.2360.doc#_ftnref3) LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 14ª ed. ver. atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2010, pág. 55.

[4] (/////tjpe195009/arquivos_bu%C3%ADque/02%20-%20SENTEN%C3%87AS/2020/05%20-%20MAIO/28-05-2020/0000505-17.2018.8.17.2360.doc#_ftnref4) Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)

Assinado eletronicamente por: INGRID MIRANDA LEITE
16/08/2024 09:48:08
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 179010858

24081609480879800000174683176

IMPRIMIR GERAR PDF